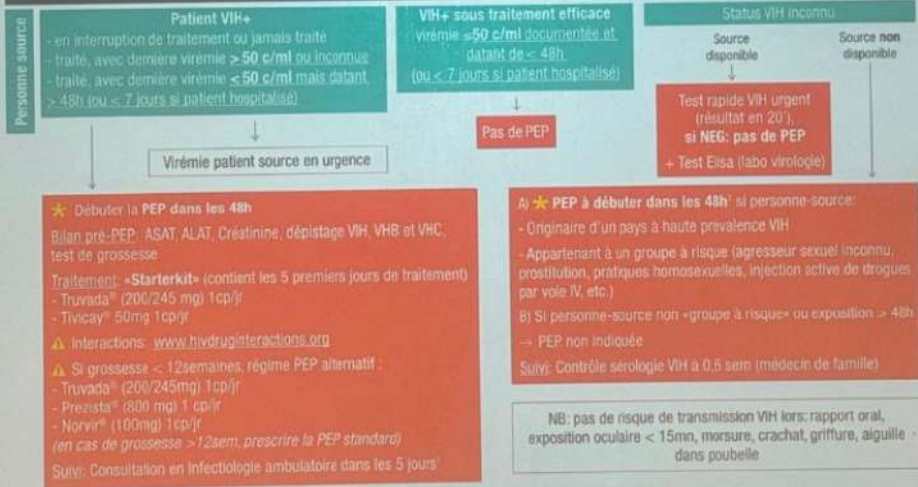


Prise en charge lors d'accident professionnel - exposition sang ou liquide biologique (AES) - VIH



AES: définition

AES = accident d'exposition au sang ou aux liquides biologiques.

Mécanisme soit :

- Effraction cutanée; piquûre, coupure, *morsure*.
- Projection sur une muqueuse (yeux, bouche, nez)
- Projection sur une peau lésée (eczéma, plaie)

AES: mesures à prendre



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
FACULTÉ DE MÉDECINE

On appelle **A**ccident d'**E**xposition au **S**ang (AES), tout contact avec du sang/liquides biologiques, comportant **une effraction cutanée** (piqûre, coupure, ...), **une projection** sur une muqueuse (yeux, bouche) ou sur une peau déjà lésée (plaie, eczéma, ...)

- **piqûre, coupure, morsure, griffure ou blessure :**
Laver immédiatement la peau à l'eau courante et savon, puis désinfecter avec chlorhexidine solution aqueuse 0,5% (laisser agir 5 minutes).
- **projection dans la bouche ou le nez :**
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante, puis avec Dentohexine 0,2%.
- **projection dans les yeux :**
(Oter les verres de contact!) rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante (ou douche oculaire), puis instiller 2-3 gouttes de collyre chlorhexidine 0,05%. Répéter après 10 minutes.
- **identifier le patient-source***
Demander les sérologies du patient-source sur REQUÊTE LABO:

AES: risque



Risque global



HIV	0.3%
HCV	3%
HBV	30%

Asthme professionnel: agents causaux



- farines/céréales 29%
- isocyanates 18%
- poussières organiques 5%
- bois 5%
- époxy 4%
- cobalt 3%
- chrome 2%
- animaux 2%
- végétaux 1%
- soudage 1%

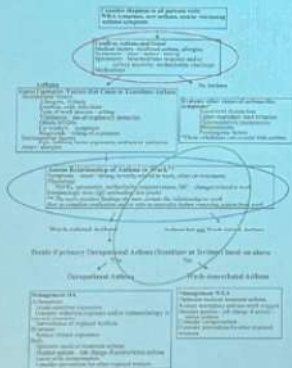
Asthme professionnel: agents causaux

	Agents de HPM	Agents de BPM
Structure	Protéines, polysaccharides	Agents chimiques, métaux...
Rhinite	92%	55%
Mécanisme immunitaire	IgE	Inconnu, rarement IgE
Cellules impliquées	Éosinophiles	Éosinophiles/Neutrophiles
Type de réaction asthmatisique	Immédiate: 61% Tardive: 9% Double: 15% Atypique: 0%	Immédiate: 31% Tardive: 23% Double: 17% Atypique: 3%

Asthme professionnel: processus diagnostique



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
FACULTÉ DE MÉDECINE



3 niveaux de tests:

1. Diagnostic
d'asthme

2. Lien entre
asthme et poste
de travail

3. Identification de
l'agent causal

Asthme professionnel: facteurs de mauvais pronostic

- Age plus élevé au moment du diagnostic
- Durée d'exposition avec des symptômes élevée
- Exposition à des agents de HPM
- Volumes pulmonaires abaissés au moment du diagnostic
- Présence d'une HRBNS importante
- Sévérité de la réponse au TPS

- Définition:

Le **BURNOUT**, ou épuisement professionnel, est un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré. Trois dimensions le caractérisent:

- un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement;
 - un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés au travail; (dépersonnalisation)
 - une perte d'efficacité professionnelle.
- Prévalence: 25% (population générale)

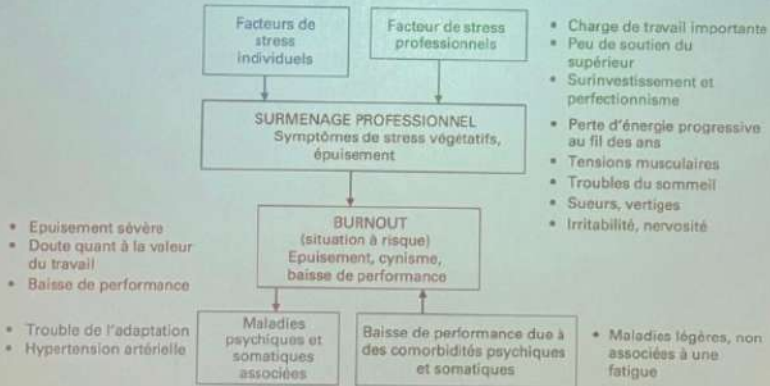
Facteurs générateurs de stress

- Exigences trop élevées
- Contrôle insuffisant
- Manque de récompense
- Sentiment d'injustice
- Conflit de valeurs
- Manque de soutien social
- Traits de personnalité

Stratégies de prise en charge

- Retrait
- Repos
- Suivi psychiatrique
- Traitement pharmacologique
- Méthodes non médicales
- Accompagnement actif
- CHANGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
- Retour progressif

Processus dynamique



Profil à risque

- Perfectionnisme
- Excès du sens des responsabilités
- Besoin excessif d'harmonie
- Recherche excessive d'admiration
- Besoin excessif de contrôle
- Besoin excessif d'autonomie

Types



- Amiante: mésothéliome, carcinome broncho-pulmonaire
- Cancers des voies urinaires
- Cancers ORL
- Autres: leucémies, tumeurs cutanées



Cas clinique

- Simone, 25 ans, formation de laborantine, travaille dans une entreprise de chimie au sein du laboratoire de contrôle qualité.
- Bonne santé habituelle
- Tabagique: 10 cigarettes/jour, 5 UPA
- Médicaments: pilule contraceptive

Catégories

- Dermatite irritative de contact
- Dermatite allergique de contact
- Urticaire
- Cancer

Epidémiologie

- 2^e cause de maladies professionnelles en CH
- > 400 cas/an (18%)
- Agents: produits chimiques, plantes, animaux, micro-organismes, contraintes physiques
- Coûts: 10-20 millions CHF/an

Prévention primaire

STOP

- Substitution
- Technique
- Organisationnel
- Personnel

Absence



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

FACULTÉ DE MÉDECINE

	Absence demandée par la travailleuse	Incapacité de travail	interdiction d'affectation	Congé maternité (14 semaines)
Documents nécessaires	Simple déclaration	Certificat médical (cause maladie)	Certificat d'incapacité au poste de travail (risque/ absence de protection)	Annonce selon LAPG
Rémunération	Pas de salaire	En général 80 %-100 % du salaire pendant une période déterminée	80 % du salaire	80 % du salaire
Prise en charge des coûts	Travailleuse	Employeur ou, le cas échéant, assurance indemnités journalières	Employeur	APG (assurance sociale)

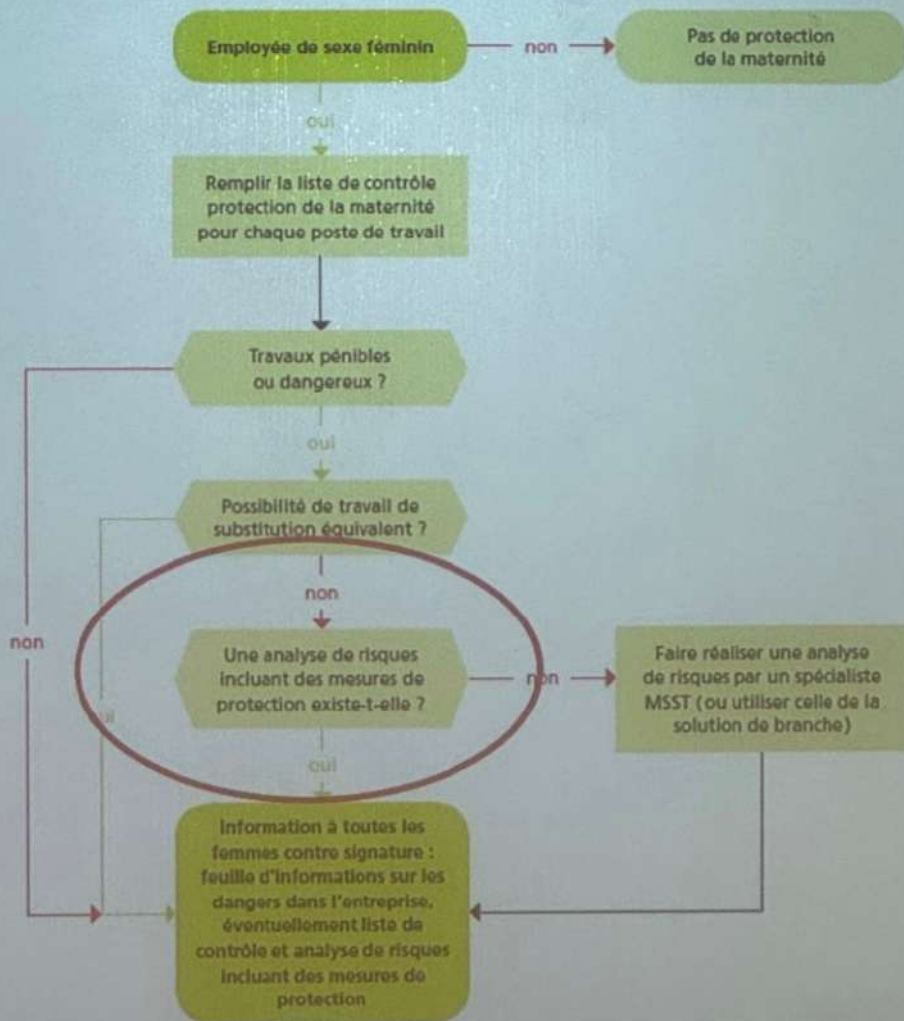


Analyse de risque

- Point central de l'évaluation en milieu de travail
- Avant toute grossesse
- Spécialiste MSST

Procédure pour la protection de la maternité en entreprise

Avant la grossesse



Question 1

Cette employée vous consulte en raison de lésions érythémateuses des mains. Elle porte des gants sur son poste de travail et se lave fréquemment les mains. Avec ces seules informations, quel(s) diagnostic(s) peut-on évoquer ?

- A. Dermate irritative de contact en raison des lavages fréquents des mains et de l'exposition aux produits chimiques
- B. Dermate allergique de contact sur un composant des gants
- C. Urticaire au latex contenu dans les gants
- D. Brûlure du 1^{er} degré

Question 2



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

FACULTÉ DE MÉDECINE

L'examen des mains retrouve des plaques érythémateuses, oedémateuses, à bordures nettes, avec un prurit. Les lésions sont apparues très rapidement après l'utilisation d'une paire de gants provenant d'un vieux stock de gants trouvé dans au fond d'un placard.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correctes ?

- A. Cette description est typique d'une dermatite irritative de contact
- B. La suspicion d'urticaire pourra être confirmée par des prick-tests au latex
- C. Des patch-tests négatifs associés à une présentation clinique peu typique rendent peu probable une dermatite allergique de contact
- D. La réaction immédiate est compatible avec le diagnostic d'urticaire, réaction d'hypersensibilité de type I, IgE médiée

Question 3

Le diagnostic d'urticaire au latex est confirmé. Que proposez-vous à votre patiente ?

- A. Ce diagnostic la rend inapte à poursuivre son activité de laborantine en chimie
- B. Dans cette situation, la substitution des gants en latex par des gants en nitrile est la meilleure façon de prévenir une récurrence
- C. Elle peut poursuivre son activité en utilisant des gants en latex mais doit être très attentive à sécher soigneusement ses mains après chaque lavage
- D. Elle peut poursuivre son activité mais sans gants pendant au moins 1 mois afin de permettre une guérison complète des mains

Question 4

Parmi les éléments suivants, lesquels sont importants à recueillir à l'anamnèse lors d'une suspicion de dermatose professionnelle ?

- A. La chronologie des lésions
- B. La localisation
- C. Les signes fonctionnels (prurit, brûlure, douleur, ...)
- D. Le statut tabagique

Question 5

Cette employée vous consulte à nouveau 6 mois plus tard car elle présente quasi systématiquement des épisodes de toux avec dyspnée vers 21h tous les soirs depuis 3 semaines. Elle travaille à l'évaluation de nouvelles formules chimiques depuis 2 mois.

Quelle(s) affirmations est/sont juste(s) ?

- A. Certains produits chimiques peuvent causer un asthme immédiat
- B. Certains produits chimiques peuvent causer un asthme retardé
- C. L'asthme causé par les agents chimiques est accompagné systématiquement par des IgE spécifiques
- D. L'atopie prédispose à un asthme causé par des agents chimiques

Question 6

Quelle est la démarche la plus appropriée pour effectuer le diagnostic?

- A. Effectuer une anamnèse professionnelle détaillée
- B. Demander la liste et les fiches de données de sécurité de l'ensemble des agents chimiques auxquels elle est exposée
- C. Effectuer une spirométrie pour rechercher un diagnostic d'asthme
- D. Tenter d'établir le lien entre les symptômes, la maladie et l'exposition aux agents chimiques en effectuant par exemple un suivi du débit expiratoire de pointe 4x/jour pendant 4 semaines
- E. Toutes ces réponses sont justes

Question 7

Le diagnostic d'asthme professionnel aux terpènes est retenu. Quelle est la meilleure prise en charge?

- A. Traitement médicamenteux immédiat avec corticostéroïdes inhalés et suivi clinique régulier chez un pneumologue
- B. Eviction stricte des terpènes
- C. Port obligatoire d'un masque respiratoire de type FFP2
- D. Aucune mesure particulière n'est à préconiser car la symptomatologie n'est pas inquiétante
- E. Suivi répété et quotidien du débit expiratoire de pointe sur le lieu de travail et initiation d'un traitement médicamenteux en cas d'aggravation de ce paramètre fonctionnel

Question 8

Cette employée est enceinte de 8 semaines. Elle n'a pas encore informé qui que ce soit sur son lieu de travail. En tant que médecin traitant, quelle est votre prise en charge?

- A. Vous lui rédigez un arrêt de travail en raison de sa fatigue et de sa gêne due aux odeurs des produits chimiques.
- B. Les conditions de travail néfastes au bon déroulement de la grossesse justifient l'arrêt de travail.
- C. Vous lui demandez s'il existe une analyse de risques de son poste de travail.
- D. Vous l'informez que l'employeur n'a pas d'obligation légale à adapter le poste de travail pénible ou dangereux d'une travailleuse enceinte.

Question 9

Quelle affirmation concernant grossesse et travail est fausse :

- A. Une femme enceinte doit donner son accord pour être employée
- B. Une femme enceinte peut travailler jusqu'à 9h par jour
- C. Une femme enceinte peut, sur simple avis, ne pas aller travailler ou s'absenter
- D. Le travail de nuit et de soir est systématiquement interdit durant toute la grossesse
- E. Le travail est interdit durant les 8 semaines suivant l'accouchement

Question 10

Depuis son retour au travail à la fin de son congé maternité, Simone s'implique énormément et effectue de nombreuses heures supplémentaires. Elle veut montrer à son chef qu'elle est toujours aussi capable et fiable et espère une promotion. A la fin décembre, elle apprend que c'est une collègue qui a obtenu la promotion et qui devient sa cheffe directe. En plus, il n'y aura pas d'augmentation salariale en raison de la situation économique mondiale. Elle est terriblement déçue.

Quels facteurs sont générateurs de stress?

- A. Le manque de reconnaissance
- B. Le sentiment d'injustice
- C. Des exigences trop élevées
- D. Un soutien social important

Question 11

Simone reçoit, vers 18h30, l'appel téléphonique de sa petite sœur, étudiante infirmière. Celle-ci est paniquée car elle vient de se piquer avec une aiguille lors d'une ponction veineuse. Elle demande de l'aide à sa sœur.

Quel est le meilleur conseil à donner à la sœur de Simone?

- A. Il est déjà tard, elle verra demain
- B. C'est une urgence, elle doit bénéficier d'une prophylaxie post-exposition à la pharmacie
- C. Un lavage et une désinfection de la plaie sont à effectuer immédiatement
- D. Il faut déclarer l'accident de travail
- E. Elle doit contacter le service de maladies infectieuses

Question 12



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
FACULTÉ DE MÉDECINE

L'entreprise déménage dans de nouveaux locaux et le poste de travail de Simone se trouve au milieu de machines bruyantes.

Concernant le bruit et le travail, laquelle (lesquelles) parmi ces affirmations est (sont) correcte(s) ?

- A. Le seuil auditif engendrant des lésions se situe à 70 dB
- B. Le seuil de la douleur se situe environ à 120 dB
- C. La surdité professionnelle est la maladie professionnelle la plus fréquente dans les statistiques des assureurs-accidents en Suisse
- D. L'exposition chronique au bruit n'a pas d'effet sur la santé en général

Question 13

Parmi les propositions suivantes concernant le bruit, laquelle est correcte :

- A. L'exposition professionnelle au bruit engendrant des problèmes provient essentiellement des conversations entre collègues
- B. La surdité liée à l'exposition chronique au bruit est une surdité de perception, insidieuse, symétrique, définitive et irréversible
- C. Dans le cadre de l'exposition professionnelle au bruit, la prévention individuelle prime toujours sur la prévention collective
- D. Les employés ne sont pas tenus d'appliquer les mesures mises en place par l'employeur en matière de prévention des problèmes de santé et accidents
- E. Dans les 4 stades successifs de la surdité liée au bruit, lors du stade 4 (surdité manifeste), le déficit auditif est très localisé (scotome à 4000 Hz) et réversible

Question 14

Simone rencontre une ancienne collègue tabagique qui a pris sa retraite il y a quelques années. Celle-ci lui annonce que son médecin lui a diagnostiqué un cancer de la vessie. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont correctes?

- A. L'exposition aux amines aromatiques est une cause de cancer de la vessie
- B. Le tabac est un co-carcinogène
- C. La profession n'est pas en cause car le cancer n'est jamais une maladie professionnelle
- D. Seule l'histologie spécifique à l'origine professionnelle permet de conclure

Question 15

Parmi les propositions suivantes concernant les cancers professionnels, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

- A. Les cancers professionnels ont des types histologiques spécifiques à leur origine professionnelle
- B. Ils sont caractérisés par une grande latence
- C. Ils sont souvent diagnostiqués après la fin de la période d'activité professionnelle
- D. Les facteurs cancérigènes environnementaux (par exemple le tabac, l'alcool) sont négligeables et ne doivent pas être pris en compte

Question 16

Dans son nouvel environnement de travail, Simone doit visser et dévisser environ 50 x/jour des flacons. Après quelques semaines, elle consulte en raison de douleurs au coude. Vous suspectez une épicondylite.

Quelles sont les propositions correctes?

- A. Les mouvements répétitifs créent et entretiennent l'inflammation
- B. Le travail n'a rien à voir avec la symptomatologie
- C. L'utilisation de moyens techniques (système automatique de vissage-dévissage par exemple) est un bon moyen d'agir en prévention primaire
- D. Certains facteurs personnels peuvent aggraver les symptômes

Question 17

En Suisse, la médecine du travail :

- A. consiste à soigner les collaborateurs d'une ou plusieurs entreprises
- B. assure des prestations de médecine des assurances pour les employés
- C. est destinée à protéger les travailleurs contre tous les risques pour la santé pouvant résulter de l'activité professionnelle
- D. a pour seule mission la prévention des accidents et maladies professionnels
- E. est la discipline chargée du traitement des accidents et maladies professionnels

Question 18

Concernant le médecin du travail :

- A. Il n'est pas soumis au secret médical
- B. Il n'effectue pas de consultation médicale individuelle
- C. Il effectue des visites de poste de travail
- D. Il y a un médecin du travail dans chaque entreprise en Suisse
- E. Seules les entreprises peuvent faire appel à un médecin du travail

Rhinite professionnelle



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
FACULTÉ DE MÉDECINE

- Facteurs de risque:
 - Atopie
 - Intensité de l'exposition
- Agents
- Complication: asthme professionnel

Bruit et surdité

- Atteintes auditives: acouphène, hypoacousise, surdité, 4 phases
- Atteintes extra-auditives: stress, troubles du sommeil, irritabilité, baisse de concentration et de vigilance, modification TA et FC

Bruit et surdité

- Maladie professionnelle la plus fréquente en CH: 800 cas/an
- Coûts: 11 mio CHF/an
- Seuil lésionnel: 85 dB(A)
- Seuil de la douleur: 120 dB(A)

TMS



- Fréquents
 - Importance de l'anamnèse professionnelle pour les identifier
- Coûts élevés pour les employés, les employeurs, et la société
- Parfois invalidants (arrêts maladie prolongés)
 - Renvois
 - Invalidités
 - Reconversion professionnelle
- Association avec le travail mais origine multifactorielle (causalité claire souvent difficilement démontrable)
- Mauvaise reconnaissance comme maladies professionnelles